

Положение Симса – это: {

~ положение сидя

~ лёжа на правом боку

~ полулёжа, полусидя

= промежуточное положение между, лёжа на животе и лёжа на боку

}

Положение Фаулера – это: {

~положение сидя

~ лёжа на правом боку

= полулёжа, полусидя

~ промежуточное положение между лёжа на животе и лёжа на боку

}

Подкладной резиновый круг после использования подлежит: {

~ утилизации

= дезинфекции

~ дезинсекции

~ стерилизации

}

К патофизиологическим факторам развития пролежней относится: {

~ сдавление

~ мацерация кожных покровов

~ трение

= сниженная масса тела

}

В развитии экзогенных пролежней основную роль играют: {

= фактор длительного сдавливания

~ фактор нарушения трофики

~ фактор ослабления организма

~ фактор нарушения иннервации

}

Основные причинные факторы приводящие к пролежням: {

~ возраст

= давление на мягкие ткани

- ~ хронические заболевания
- ~ травма конечностей

}

Для удаления корочек из носовой полости пациента используется {

- ~70 град. этиловый спирт;

- = вазелиновое масло;

- ~ 10 % раствор камфорного спирта;

- ~ 3 % раствор перекиси водорода;

- ~ Глицерин.

}

При смене постельного белья (пациент в постели) одним медработником простыню скатывают в следующем направлении {

- ~ в поперечном направлении со стороны изголовья;

- ~ в поперечном направлении со стороны ног;

- = в продольном направлении от себя;

- ~ в продольном направлении к себе;

}

Грязную простыню при смене постельного белья тяжелобольному продольным способом следует {

- = скатать валиком, и положить под спину пациенту;

- ~ скатать валиком и положить под живот пациенту;

- ~ осторожно выдернуть из-под пациента;

- ~ собрать у изголовья кровати;

- ~ собрать у ножного конца кровати.

}

Выберете наиболее полный ответ медицинская сестра при смене белья и одежды тяжелобольному должна приготовить {

~ перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, комплект чистого нательного белья, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое мыло;

~ перчатки нестерильные, ветошь, комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое мыло;

~ перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня;

= перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое мыло;

~ ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое мыло.

}

После окончания процедуры по смене нательного белья, следует {

~ устно сказать лечащему врачу;

~ сказать старшей медицинской сестре;

= сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинскую документацию;

~ сказать сестре хозяйке;

~ данная процедура не требует вносить соответствующую запись в медицинскую документацию.

}

Укажите последовательность обработки наружных половых органов у женщины {

~ наружные (большие) половые губы, область лобка, паховые складки, промежность, область анального отверстия, межъягодичная складка;

~ паховые складки, промежность, область лобка, наружные (большие) половые губы, область анального отверстия, межъягодичная складка;
~ межъягодичная складка, область анального отверстия, область лобка, наружные (большие) половые губы, паховые складки, промежность;
= область лобка, наружные (большие) половые губы, паховые складки, промежность, область анального отверстия, межъягодичная складка;
~ промежность, область лобка, наружные (большие) половые губы, паховые складки, область анального отверстия, межъягодичная складка.

}

Укажите последовательность обработки наружных половых органов у мужчины{

= обработать головку полового члена, кожу полового члена, мошонку, паховые складки, область заднего прохода, межъягодичную складку;
~ обработать мошонку, головку полового члена, кожу полового члена, паховые складки, область заднего прохода, межъягодичную складку;
~ обработать паховые складки, область заднего прохода, межъягодичную складку, головку полового члена, кожу полового члена, мошонку;
~ обработать межъягодичную складку, головку полового члена, кожу полового члена, мошонку, паховые складки, область заднего прохода.

}

Подмывание больных проводят{

~ 1 раз в сутки, а также после каждого акта дефекации у всех больных, у женщин после каждого мочеиспускания;
= 2 раза в сутки, а также после каждого акта дефекации у всех больных, у женщин после каждого мочеиспускания;
~ 3-4 раза в сутки, а также после каждого акта дефекации у всех больных;
~ по назначению врача, а также после каждого акта дефекации у всех больных, у женщин после каждого мочеиспускания;
~ по просьбе родственников, а также после каждого акта дефекации у всех больных, у женщин после каждого мочеиспускания.

}

Уход за лицом тяжелобольного выполняют в следующей последовательности{

~ щеки, нос, веки, лоб, область вокруг рта, уши, подбородок, шея;
~ область вокруг рта, веки, лоб, щеки, нос, уши, подбородок, шея;
~ веки, лоб, щеки, подбородок, нос, область вокруг рта, уши, шея;
= веки, лоб, щеки, нос, область вокруг рта, уши, подбородок, шея;
~ уши, подбородок, шея, веки, лоб, щеки, нос, область вокруг рта
}

Выберите наиболее полный ответ. Медицинская сестра для мытья головы тяжелобольного должна приготовить {

~ перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, шампунь, жидкое мыло, щетка для волос, расческа, полотенце, мешок для грязного белья, ёмкость для воды;
~ перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, кожный антисептик, шампунь, жидкое мыло, полотенце, мешок для грязного белья, ёмкость для воды;
= перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, кожный антисептик, шампунь, жидкое мыло, щетка для волос, расческа, полотенце, мешок для грязного белья, ёмкость для воды;
~ перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, кожный антисептик, шампунь, жидкое мыло, щетка для волос, расческа, полотенце, ёмкость для воды;
~ перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, кожный антисептик, шампунь, жидкое мыло, щетка для волос, расческа, полотенце, мешок для грязного белья. }

Чистку зубов тяжелобольному пациенту начинают с {

~ внутренней поверхности;
= с задних зубов;
~ с передних зубов;
~ с наружной поверхности;
~ не имеет значения.

}

При обработке полости рта тяжелобольному пациенту, обработку языка начинают с {

- ~ от кончика языка к корню;
- = от корня к кончику языка;
- ~ от коренных зубов;
- ~ спиралеобразно;
- ~ не имеет значения

}

Для профилактики пролежней, положение пациента следует менять {

- ~ каждые 3 часа;
- = каждые 2 часа;
- ~ каждые 4 часа;
- ~ по назначению врача;
- ~ на усмотрение медицинской сестры.

}

Наиболее частая область образования пролежней у тяжелобольного пациента при положении на спине {

- ~ голень;
- ~ икроножная мышца;
- = крестец;
- ~ бедро;
- ~ ягодицы.

}

При проведении гигиенической обработки полости рта тяжелобольного, пациента следует расположить в следующих положениях {

- ~ сидя с опущенными ногами;
- ~ сидя на стуле лицом к себе;
- = на спине под углом более 45° , если это не противопоказано, или лежа на боку, или лежа на животе (или спине), повернув голову вбок;
- ~ на спине под углом 90° ;
- ~ на спине, убрав подушку из-под головы.

}

Определите правильную последовательность обработки рта {

~ пространство под языком, язык, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны пациента;

= зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под языком, дёсны пациента;

~ внутренняя поверхность щёк, зубы, язык, пространство под языком, дёсны пациента;

~ дёсны пациента, зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под языком;

~ язык, пространство под языком, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны пациента.

}

Чего нельзя допускать при расположении на боку пациента с риском возникновения пролежней {

~ чтобы пациент лежал в положении полубок- полуживот;

~ чтобы пациент сгибал ноги в коленях;

~ чтобы пациент перемещался самостоятельно;

= чтобы пациент лежал непосредственно на большом вертеле бедра;

~ чтобы пациент лежал, упираясь ногами в ограничитель.

}

Выберите наиболее полный ответ. Медицинская сестра для ухода за ногтями тяжелобольного должна приготовить {

~ перчатки стерильные, кожный антисептик, жидкое мыло, ёмкость для воды, крем для рук;

~ салфетки, перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, жидкое мыло, ёмкость для воды, крем для рук;

~ перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, кожный антисептик, ёмкость для воды, крем для рук, салфетки;

~ ёмкость для дезинфекции, перчатки нестерильные, кожный антисептик, жидкое мыло, салфетки;

= перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, кожный антисептик, жидкое мыло, ёмкость для воды, крем для рук, салфетки.

}

Порционное требование палатная медсестра составляет: {

= ежедневно

~ 1 раз в неделю

~ 2 раза в неделю

~ 1 раз при поступлении пациента

}

Химически щадящая диета достигается при: {

= при исключении из рациона продуктов вызывающих усиления секреции пищеварительных желез

~ определенной кулинарной обработке

~ уменьшении общей массы пищевого рациона

~ назначении голода

}

Для диеты №10 характерно: {

~ ограничение углеводов

~ ограничение белков, жидкости

= ограничение животных жиров, соли, продуктов богатых холестерином

~ физиологически полноценная пища с удвоенным содержанием витаминов

}

Диета № 3 назначается при заболевании: {

~ печени и желчевыводящих путей

~ обострения язвенной болезни в стадии затихания

= кишечника с преобладанием запоров

~ кишечника с профузными поносами

}

Диета в которой исключаются кислые фрукты, ягоды, шоколад, пряности, щавель: {

= 5

~ 7

~ 15

~ 4

}

8. При заболеваниях печени назначается диета:

{ ~ 1

~ 4

=5

~ 0}

В первые дни после операции на желудке и кишечнике назначается диета: {

~ 1

~ 3

= 0

~ 2

}

Соотношение белков, жиров и углеводов при сбалансированном питании должно быть: {

~ 1:2:4

~ 2:1:6

= 1:1:4

~ 2:4:4

}

Рациональное питание больного определяется: {

~ %25% энергетическими потребностями;

~ %25% пластическими потребностями;

~ %25% вкусовыми качествами пищи;

~ %25% оптимальным соотношением в пище белков, жиров и углеводов;

~ %-100% преобладанием энергоёмких питательных веществ

}

Искусственное питание больных через гастростому применяется {

~ при бессознательном состоянии;

~ при опухоли прямой кишки;

~ при непроходимости кишечника;

= при опухоли пищевода;

~ всё перечисленное верно.

}

Для диеты № 10, характерно {

~ ограничение углеводов;

= ограничение животных жиров, соли, продуктов, богатых холестерином, жидкости;

- ~ физиологически полноценная пища;
- ~ ограничение белков, жидкости;
- ~ всё перечисленное верно.

}

Объем жидкой пищи при очередном кормлении взрослого пациента через зонд (в мл){

- ~ 600 — 800;
- ~ 250 — 450;
- = 100 — 150;
- ~ 20 — 50;
- ~ 1000 — 1500.

}

Чтобы рассчитать длину зонда, достигающего желудка при введении через нос, нужно{

- ~ ориентироваться на расстояние от уха до мечевидного отростка;
- = сложить расстояния от кончика носа до ушной раковины и от уха до мечевидного отростка;
- ~ сложить расстояния от подбородка до ушной раковины и от уха до мечевидного отростка;
- ~ ориентироваться на расстояние от подбородка до мечевидного отростка;
- ~ любой из перечисленных вариантов.

}

Искусственное энтеральное питание (в любом количестве) через зонд противопоказано в следующих случаях{

- ~%33.3% клинически выраженный шок;
- ~%33.3% ишемия кишечника;
- ~%33.3%кишечная непроходимость;
- ~%-100%язва желудка

}

Гастростомия – создание оперативным путём наружного свища для энтерального питания через{

- ~ прямую кишку;
- ~ 12-ти перстную кишку;
- ~ трахею;
- = желудок;
- ~ всё перечисленное неверно.

}

Парентеральным называют питание посредством[

- ~ илеостомы;
- ~ еюностомы;
- ~ трахеостомы;
- = внутривенных капельных вливаний;
- ~ всё перечисленное, неверно.

}

Для искусственного кормления тяжелобольного необходим предмет ухода{

- ~ система для внутривенного капельного введения жидкости;
- ~ дуоденальный зонд;
- ~ газоотводная трубка;
- =назогастральный зонд

}

Оптимальный режим питания здорового, взрослого человека{

- ~ 2-х разовый;
- ~ 3-х разовый;
- = 4-х разовый;
- ~ 5-ти разовый;

}

Соотношение белков, жиров и углеводов у взрослого человека должно быть{

~ 1:1:1;
~ 1:2:4;
= 1:1:4;
~ 1:1:3;

}

Для того чтобы убедиться в правильном местоположении зонда в желудке, необходимо {

= ввести через зонд 20 мл воздуха с помощью шприца Жане;
~ ввести через зонд 50 мл кипяченой воды с помощью шприца Жане;
~ ввести через зонд 500 мл капустного отвара с помощью шприца Жане;
~ ввести через зонд 50 мл марганцево-кислого калия с помощью шприца Жане;

}

Если назогастральный зонд остается в желудке на длительное время, его необходимо промывать {

= каждые 4 часа изотоническим раствором хлорида натрия;
~ растительным маслом каждые 4 часа;
~ перекисью водорода каждые 2 часа;
~ 0,05% марганцовокислого калия каждые 5 часов;
~ стерильным глицерином каждые 3 часа.

}

Для диеты № 10, характерно {

~ ограничение углеводов;
= ограничение животных жиров, соли, продуктов, богатых холестерином, жидкости;
~ физиологически полноценная пища;
~ ограничение белков, жидкости;

}

При заболеваниях, не требующих назначения специальной диеты, рекомендуется диета {

= № 15;
~ № 13;
~ № 11;
~ № 10;
~ № 4.
}

Жидкость, соль ограничивают при диете{

= № 10;
~ № 9;
~ № 8;
~ № 5;
~ № 4.

}

Чтобы рассчитать длину зонда, достигающего желудка при введении через нос, нужно{

~ ориентироваться на расстояние от уха до мечевидного отростка;
= сложить расстояния от кончика носа до ушной раковины и от уха до мечевидного отростка;
~ сложить расстояния от подбородка до ушной раковины и от уха до мечевидного отростка;
~ ориентироваться на расстояние от подбородка до мечевидного отростка;
~ любой из перечисленных вариантов.

}

Возможные осложнения неправильного введения назогастрального зонда{

~%33.33% признаки интубации трахеи (кашель, нарушение дыхания);
~%33.33% перфорация лёгкого;
~%33.33% перфорация плевры;

~%100% кровотечение из носоглотки

}

Назогастральный зонд достигает{

= желудка

~ толстой кишки;

~ кардиального сфинктера желудка;

~ илеоцекального угла;

}

Гастростомия – создание оперативным путём наружного свища для энтерального питания через{

~ прямую кишку;

~ 12-ти перстную кишку;

~ трахею;

= желудок;

}

Естественное питание человека осуществляется{

~ парентерально

~ назогастрально

= перорально

~ с помощью гастростомы

}

При парентеральном питании используют{

~ питательные смеси

~ жидкую пищу

~витаминизированую пищу

= белковые, жировые, углеводные препараты

}

33. Калорийность суточного рациона взрослого здорового человека{

~ 1000-2000 ккал

= 2000-3000 ккал

~ 3000-4000 ккал

~ 4000-5000 ккал

}

Температура горячих блюд не превышает{

~15°C
~30°C
=60°C
~70°C
}

Кто определяет вид лечебного питания {
=врач
~процедурная медсестра
~старшая медсестра
~заведующий отделением
}

Механическая обработка предусматривает {
~отваривание
~тушение
=измельчение
~ приготовление на пару
}

Наука о питании называется: {
=диетология
~фримакология
~ вертробрология
~нутрициология
}

Суточная энергетическая ценность рациона человека углеводами обеспечивается {
~на 5-10%
~на 10-15%
~на 30-35%
=на 50%
}

Суточная энергетическая ценность рациона человека белками обеспечивается {
~на 5-10%
=на 10-15%
~на 30-35%

~на 50%

}

Источником углеводов является{

~рыба

~мясо

~морепродукты

=овощи

}

Для кормления пациента через назогастральный зонд необходимо{

~%33.33%~лоток;

~%33.33%~чистые перчатки;

~%33.33%~фонендоскоп;

~%-100%~газоотводная трубка

}

Действия при кормлении через зонд{

~%25%~Помочь пациенту занять положение Фаулера

~%35%~Открепить зонд от одежды. Снять зажим (заглушку) с зонда.
Присоединить воронку к зонду.

~%20%~Наливать в воронку приготовленную пищу малыми порциями,
подогретую (38-40°C) по 150-200 мл 5-6 раз в день. .

~%20%~Промыть зонд теплой кипяченой водой через шприц Жане (50 мл

~%-100%~Придать положение Симса}

